

Anamnèse (et status) en présence d'état fébrile ou inflammatoire et anamnèse alimentaire

Table des matières

1) Anamnèse d'état fébrile ou inflammatoire.....	1
1.1) Généralités.....	1
1.2) Anamnèse d'un état fébrile infectieux.....	2
1.3) Anamnèse d'un état fébrile non-infectieux.....	3
1.4) Que faire en cas de fièvre d'origine non-déterminée.....	3
2) Anamnèse alimentaire.....	4

1) Anamnèse d'état fébrile ou inflammatoire

1.1) Généralités

On mesure les températures tympanique ou rectale, les autres variant trop. On définit la fièvre comme une température rectale dépassant 37.6°C à 6h du matin ou 38.1° à 16h ou par une température tympanique > 38°C 2 fois à 30 minutes d'intervalle ou > 38.5° une fois seulement.

Il faut mesurer la température si la personne a des sudations nocturnes, ressent une fatigue permanente, a des sensations de chaleur ou de froid, si elle frissonne ou si elle ressent des douleurs articulaires, musculaires ou a des céphalées.

Les causes principales des fièvres sont infectieuses (50% des cas) ou inflammatoire. Une fièvre peut être continue, intermittente (= pics avec température normale entre les pics), rémittente (= pics avec température trop haute entre les pics) ou ondulante (typiquement tumorale, par exemple chez les lymphomes).

Les frissons lors des fièvres peuvent être « petits » ou solennels (fait trembler le lit, souvent bactérien et de mauvais pronostic).

Il existe les fièvres d'origine indéterminée (FUO), qu'on pose quand :

- Température de > 38.3°C sans origine encore défini
- > 3 semaines
- ≥ 3 visites ambulatoires ou ≥ 3 jours à l'hôpital

La plupart de ces fièvre sont dues à des infections (50%) ou à des connectivites (20% = des maladies auto-immunes).

Pour différencier les fièvres infectieuses des fièvres non-infectieuses, on va :

- Anamnèse et status + drapeaux rouges
- Examens complémentaires
 - FS ± CRP et PCT

- Cultures ± sérologies et PCR
- Bilan immunologique
- Imagerie
- Biopsies

1.2) Anamnèse d'un état fébrile infectieux

Anamnèse :

- 1) Timing de la fièvre (apparition, durée, périodicité)
- 2) Foyer => anamnèse de tous les systèmes et **raideur de nuque**
- 3) Symptômes B (= sudations nocturnes, perte de poids, asthénie, fièvre prolongée, frissons, etc.)
- 4) Baisse de défenses (maladies chroniques, anomalies anatomiques, immunosuppression)
- 4) Exposition (malades, soignants, animaux, métier, voyage (prophylaxies et vaccinations !), pays d'origine)
- 5) Opérations récentes (dans les 3 premiers jours, vient typiquement de l'opération en elle-même et/ou des atélectasies pulmonaires ; plus tard, les causes peuvent être thrombo-emboliques, infectieuses, à cause des sondes, des fuites d'anastomoses, des cathéters, etc.)
- 6) Anamnèse personnelle et familiale d'infection récidivantes (= suspicion génétique)
- 7) Antécédents personnels

Drapeaux rouges :

- Immunosuppression (sévère) : risque de sepsis fulminant ! Retrouvé dans les asplénies, hypogammaglobulinémies, neutropénies, infections à VIH, etc., mais également tous les traitements anti-tumoraux (chimio- et radio-thérapies, corticothérapie, etc.)
- Hypotension et/ou tachycardie : signe de sepsis sévère, voire de choc septique (ex. uro- ou cholangio-sepsis)
- Insuffisance respiratoire : typiquement avec P. Jiroveci chez les greffés ou les patients avec SIDA
- Atteinte SNC (= raideur de nuque, céphalée, etc.) ± lésions cutanées hémorragiques (pétéchiales) : doit immédiatement faire penser à une méningite bactérienne (sur méningocoque ou pneumocoque, les deux plus fréquents)
- Nouveau souffle cardiaque ± signes de dissémination hématogène (= lésions de Janeway (pétéchies), nodules d'Osler (nodules douloureux), tâches de Roth (oeil), hémorragie conjonctivale, hémorragie en flammèches (ongles), manifestations neurologiques (30%), etc.) : doit faire penser à une endocardite disséminée
- Retour de voyage (± lésions cutanées hémorragiques) :
 - Très fréquent : gastro-entérite bactérienne ou virale

- Souvent : malaria (fièvre tertiaire avec *ovale*), dengue (même symptômes qu'une grippe, avec des éruptions cutanées en plus, puis quelques saignements bénins. La dengue hémorragique est par contre très grave, avec des hémorragies massive et choc hémorragique), fièvre hémorragique (ex. : dengue, fièvre jaune, ébola, etc.), rickettsioses (piqûres de tiques)
- Plus rarement : fièvre typhoïde (dissociation sphygmo-dermique), hépatite (rapports non-protégés), tuberculose, VIH
- Infections sévères sans fièvre ou avec hypothermie : personnes âgées, sous anti-pyrétiques, immunosupprimées, IRC, etc.

1.3) Anamnèse d'un état fébrile non-infectieux

Causes les fréquentes (= inflammatoires) :

- Néoplasies
- Vasculites
- Connectivites
- Maladies auto-immunes
- Arthropathies micro-cristallines (ex. : goutte)
- Fièvres auto-inflammatoires (typiquement pédiatriques)

Anamnèse :

- 1) Timing de la fièvre (apparition, durée, périodicité)
- 2) Foyer => anamnèse de tous les systèmes et **raideur de nuque**
- 3) Symptômes B (= sudations nocturnes, perte de poids, asthénie, fièvre prolongée, frissons, etc.)
- 4) Anamnèse personnelle et familiale de maladies génétiques inflammatoires
- 5) Opérations récentes (dans les 3 premiers jours, vient typiquement de l'opération en elle-même et/ou des atélectasies pulmonaires ; plus tard, les causes peuvent être thrombo-emboliques, infectieuses, à cause des sondes, des fuites d'anastomoses, des cathéters, etc.)

1.4) Que faire en cas de fièvre d'origine non-déterminée

Anamnèse :

- Caractériser la fièvre (intensité, fréquence, type, symptômes associés)
- Anamnèse de tous¹ les systèmes (mais n'a pas besoin d'être super pointue = elle ne sert qu'à exclure les infections possibles)
- Antécédents personnels
- Anamnèse personnelle

1 = cardio-vasculaire, pulmonaire, digestif, génito-urinaire, ostéo-articulaire, dermatologie et neurologique

- Anamnèse familiale

Status :

- Dépend totalement des indices laissés par l'anamnèse, mais demande quasiment systématiquement un status cardio-pulmonaire
- Recherche de signes méningés **bactériens** : on retrouve une triade classique (quand la méningite est bactérienne) : (1) maux de tête, (2) raideur de nuque² et (3) fièvre. Si on ne trouve pas deux de ces signes, on peut pratiquement exclure une méningite bactérienne !
- Palper les aires ganglionnaires du cou
- Rechercher un souffle cardiaque (=> endocardite)
- Percuter les reins (=> pyélonéphrite)
- Percuter la colonne vertébrale (=> spondylodiscite)

Examens complémentaires :

- Laboratoire (FSC et CRP/PCT)
- Culture d'urines
- Radiographie thoracique
- Antibiothérapie d'abord puis PL si signes méningés positifs

Globalement, les fièvres rencontrées à l'hôpital sont presque toujours causées par des infections, qu'elles soient bactériennes ou virales ; en cas de suspicion de méningite, on fera la différence entre les deux par la recherche des signes méningés + la PL³.

Une forte fièvre continue durant plusieurs jours doit toujours faire penser à 3 grands diagnostics

- VIH : chez tout homme de plus de 20 ans, systématiquement partir dans une anamnèse sexuelle et rechercher des rapports non-protégés, récents ou anciens !
- Endocardite : peut ne se manifester que par une forte fièvre
- Spondylodiscite (= infection d'un disque inter-vertébral et des vertèbres adjacentes) : peut ne se manifester que par une forte fièvre

2) Anamnèse alimentaire

Anamnèse :

- 1) État général = les 5 A :
 - Apathie : moral
 - Asthénie : force/activités
 - Anorexie : quantité d'aliments ingérée. Fait appel au rappel de 24h, aux différences d'appétit et aux exclusions alimentaires. Attention, car la diminution des apports est naturelle avec l'âge, mais peut venir d'une dépression (30%) ou être intentionnelle (20%). Attention également au fait qu'une personne âgée qui

² Tests de flexion de la nuque, Brudzinsky, Lasègue et Kernig

³ Suspicion de méningite bactérienne : toujours faire la séquence AB => imagerie => PL => glucose sanguin

- perd du poids ne le retrouvera plus, contrairement à une personne jeune !
- Amaigrissement : le poids (BMI) et son évolution
 - Apyrexie : température > 37°C ?
 - 2) Composition corporelle
 - Composée de la masse maigre (pronostique et fonctionnelle ; sa part musculaire diminue naturellement avec l'âge (~ 40%)) et de la masse grasse (réserves et fragilité ; augmente avec l'âge). En général, le poids tend à augmenter jusqu'à 70 ans, puis diminue
 - Une diminution involontaire de la masse maigre chez un sujet bien portant accompagnée d'une diminution de la masse, force ou fonction musculaires s'appelle la sarcopénie et touche ~ 5% des personnes de plus de 70 ans
 - La composition corporelle sera donc évaluée par une éventuelle fonte musculaire ou graisseuse, par exemple via l'examen physique ou le pli cutané tricipital et la circonférence musculaire brachiale
 - 3) Fonction des organes
 - Touche principalement les muscles (tous types, autant squelettiques que cardiaque ou respiratoire ou de déglutition), mais la dénutrition protéino-énergétique touche tous les organes, tant leur structure que leur fonction. Peut aussi toucher l'immunité et provoquer des anémies (déjà très tôt)
 - 4) Balance énergétique
 - Se compose des (1) apports, des (2) pertes et des (3) besoins ; le tout est à calculer en kcal/jour
 - 5) Métabolisme
 - Les personnes âgées sont touchées par des altérations du métabolisme protéique (ne synthétisent plus aussi bien qu'avant et vont vite puiser dedans), développent une insulino-résistance (= augmente l'incidence des diabètes de type II) et ont des perturbations dans la lipogenèse (oxydent moins, mais synthétisent davantage)
 - Chez les personnes âgées, on retrouve aussi une perte de la satiété et une renutrition difficile. De plus, plus le BMI est faible (= plus la part de masse maigre augmente/plus la part de masse grasse diminue), plus les besoins énergétiques pour un même poids vont augmenter !